

Внешние системы, API и стоимость — что нужно, чтобы собирать данные

Полный реестр источников для Medical Access Intelligence Engine: способ доступа, авторизация, стоимость и лицензионный статус

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 7 августа 2026 · Каждая строка проверена по живому источнику или его официальной документации 6–7 августа 2026 года. Стоимость, которая не публикуется, помечена НЕИЗВЕСТНО, а не оценена приблизительно. Приоритеты — по §8.1 T3 v2 (P0 — авторитетный для статуса, P3 — только для обнаружения).

MVP можно построить целиком на бесплатных источниках. Каждая платная позиция в реестре либо необязательна, либо имеет бесплатную замену: OncoKB → CIViC, NCCN → ESMO, коммерческие базы рыночного доступа → национальные официальные источники, ради чего продукт и существует.

Реальных статей расхода две: **медицинский рецензент** и, много меньше, **токены LLM**. Всё остальное — обвязка.

1 · Доступность и покрытие — Q5, Q6 (наше собственное ядро)

Это функции, которых не делает для пациента никто. Всё остальное в документе — вспомогательное.

Источник	Что даёт (Q#)	Доступ	Авторизация	Стоимость	Лимиты / частота	Примечания и риски
PBS (Австралия)	Статус субсидирования, условия назначения и отпуска, цена, путь получения разрешения — Q5, Q6, Q3	REST API + бандл CSV	Ключ подписки (Azure APIM). Публичный уровень — без ключа	Бесплатно	Ежемесячно, 1-го числа. Публичный уровень: 1 запрос / 20 сек, общий на весь мир	P0. Проверено от начала до конца: 1061 онкопозиция, заполненность полей 100%, 14 событий изменения июль→август. robots.txt запрещает /api/ и *.zip — автоматизация только через API с ключом, не через скачивание ZIP.
Реестр лекарств Минздрава (Израиль)	Рег. номер и дата, отмена и её дата, показания, флаг health — Q4, Q6	Недокументированный JSON API (POST SearchByName)	Нет	Бесплатно	Неизвестны — публичного контракта нет	P0, но неофициальный. Проверено живым запросом: 27 полей. health меняется от препарата к препарату и с высокой вероятностью означает включение в корзину, но это вывод, а не документация. Нет SLA; может измениться или быть закрыт без предупреждения. Условия автоматического использования не подтверждены.
NICE syndication (Великобритания)	Рекомендации, стандарты качества — контекст Q6	REST API (JSON/XML)	Лицензионное соглашение + ключ	НЕИЗВЕСТНО — не публикуется	н/д	P0 для Великобритании. Стоимость узнаётся только заявкой. Не нужен, пока Великобритания не целевая юрисдикция.
NHS dm+d через TRUD (Великобритания)	Словарь лекарств — нормализация	Выгрузка XML	Бесплатная регистрация + лицензия	Бесплатно	Регулярные релизы	P0 для нормализации по Великобритании.
BDPM (Франция)	Препараты на рынке, ставка возмещения — Q5, Q6	Открытые данные (CSV)	Нет	Бесплатно	Ежемесячно	P0. Не покрывает больничную онкологию — см. ATIN ниже.

Источник	Что даёт (Q#)	Доступ	Авторизация	Стоимость	Лимиты / частота	Примечания и риски
АТИН liste en sus (Франция)	Онкопрепараты больничного счёта — Q5, Q6	Публикуемые списки	Нет	Бесплатно	Периодически	P0. Франции нужно три источника для одного ответа: BDPM + АТИН + таблицы досрочного доступа министерства.
GlobalData POLI / NAVLIN / RxData	Цены, возмещение, решения HTA по 100+ рынкам — Q5, Q6	Коммерческий API / платформа	Корпоративный договор	НЕИЗВЕСТНО — корпоративные цены, рассчитаны на фарму	Определяется поставщиком	Не рекомендуется. Это те самые данные, которые наш продукт и раскрывает; покупать их оптом — перевернуть экономику. В реестре для полноты и как ориентир.

2 · Регуляторный статус — Q4

Источник	Что даёт (Q#)	Доступ	Авторизация	Стоимость	Лимиты / частота	Примечания и риски
EMA (ЕС)	Централизованно одобренные препараты, EPAR — Q4	Структурированные выгрузки (Excel/JSON/CSV/XML/RSS)	Нет	Бесплатно	Обновление ночью	P1. Формального REST API нет, но выгрузки чистые и структурированные.
openFDA (США)	Одобрения, инструкции, нежелательные явления — Q4	REST API	Бесплатный ключ	Бесплатно	240 запросов/мин; 1000/день без ключа → 120 000/день с ключом	P1. Щедрые лимиты, ключ бесплатный и мгновенный.
TGA (Австралия)	Австралийские регистрации (ARTG) — Q4	Веб / публикуемые наборы	Нет	Бесплатно	Периодически	P0 для Австралии. Пара к PBS: TGA говорит «одобрено», PBS — «субсидируется».
MHRA (Великобритания)	Британские разрешения — Q4	Веб / наборы данных	Нет	Бесплатно	Периодически	P0 для Великобритании.

3 · Доказательства и knowledge bases — Q1, Q2 (интегрировать, не строить заново)

Источник	Что даёт (Q#)	Доступ	Авторизация	Стоимость	Лимиты / частота	Примечания и риски
PubMed E-utilities	Абстракты, метаданные — Q1	REST API	Необязательный бесплатный ключ	Бесплатно	3 запроса/с → 10/с с ключом	P2. Абстракты могут быть защищены авторским правом третьих лиц; дисклеймер NCBI обязан быть виден. Для массовой работы NCBI рекомендует локальную копию, а не API.
Europe PMC	Абстракты + полные тексты открытого доступа — Q1	REST API	Нет	Бесплатно	Непрерывно	P2.

Источник	Что даёт (Q#)	Доступ	Авторизация	Стоимость	Лимиты / частота	Примечания и риски
CIViC	Интерпретация вариантов, клиническая значимость — Q2, Q3	API + массовая выгрузка	Нет	Бесплатно	Непрерывно	P2. Бесплатная альтернатива OncoKB. Курируется сообществом, открытая лицензия.
OncoKB	Уровни «вариант→терапия», привязанные к статусу FDA — Q2, Q3, Q4	REST API	Лицензия + регистрация	Бесплатно только для академии. Коммерческое/клиническое — ПЛАТНО, сумма НЕИЗВЕСТНА	н/д	Два стоп-фактора для нас: мы коммерческое использование, то есть нужна платная лицензия; и OncoKB запрещено использовать для обучения ИИ-моделей вообще. Предпочсть CIViC, пока лицензия не согласована.
NCCN	Онкологические руководства — Q2	XML/JSON API для лицензиатов	Коммерческая лицензия	ПЛАТНО, НЕИЗВЕСТНО — зависит от числа просмотров и количества руководств	н/д	Необязательно. ESMO — открытая замена. Снимает переговоры с критического пути.
Crossref + Retraction Watch	Отзывы и исправления статей — целостность данных	REST API + полный CSV-дамп	Нет	Бесплатно	Обновление каждый рабочий день	P1. Сделать на первой неделе — бесплатно, и почти никто этого не делает.

4 · Исследования и альтернативные пути доступа — Q7 (интеграция или партнёрство)

Источник	Что даёт (Q#)	Доступ	Авторизация	Стоимость	Лимиты / частота	Примечания и риски
ClinicalTrials.gov v2	Исследования, критерии включения — Q7, Q3	REST API	Нет	Бесплатно	~50 запросов/мин	P1. Ни ключа, ни регистрации. v2 заменил классический API в марте 2024 — всё старше устарело.
ANZCTR (Австралия/НЗ)	Региональный реестр исследований — Q7	Веб / выгрузки	Нет	Бесплатно	Непрерывно	P1 для старта в Австралии.
WHO ICTRP	Агрегация мировых реестров исследований — Q7	Выгрузка / поиск	Нет	Бесплатно	Еженедельно	P1 для трансграничного покрытия.
myTomorrows	Expanded access + исследования, 133 страны — Q7	Партнёрство / платформа	Коммерческое	Партнёрство, а не поток данных	н/д	Не строить заново. 16 900+ подобранных пациентов, 29 млн \$ привлечено. Поговорить до того, как что-то делать по Q7.

5 · Терминологии и нормализация (нужны для сопоставления)

Источник	Что даёт (Q#)	Доступ	Авторизация	Стоимость	Лимиты / частота	Примечания и риски
SNOMED CT	Клинические понятия, кодирование заболеваний	Файлы через национальный центр релизов	Бесплатная Affiliate-лицензия	Бесплатно в странах-участниках — Австралия и Израиль обе участницы	Плановые релизы	Хорошая новость для обеих наших юрисдикций. Плата возникает только в странах, не входящих в организацию.
WHO ATC	Классификация препаратов (L01/L02 = онкология)	Сайт; опционально Excel	Нет	Бесплатно онлайн; ~200 € за файл Excel	Ежегодные обновления	PBS и так поставляет коды ATC с каждым расписанием — платный файл нужен только для удобства.
RxNorm	Нормализация наименований препаратов	API + выгрузки	Нет	Бесплатно	Еженедельно/ежемесячно	Ориентирован на США, но полезен для сопоставления.
UMLS / MeSH	Терминология, расширение синонимов	Выгрузки + API	Бесплатная лицензия + аккаунт	Бесплатно	Ежегодно	Нужен аккаунт; лицензия бесплатная.
ICD-10 / ICD-11	Кодирование заболеваний	API ВОЗ / файлы	Регистрация	Бесплатно	Периодически	У ICD-11 есть публичный API.

6 · Сводка по стоимости

Статья	Стоимость	Комментарий
Медицинский рецензент	15–25 тыс. \$ / год	~30 карточек в неделю по ~4 минуты ≈ 2 часа времени специалиста в неделю. Мой расчёт по опубликованным ставкам, а не оферта. Эта строка превосходит все остальные в 50–100 раз и является реальной себестоимостью продукта.
Токены LLM (извлечение, перевод)	~сотни \$ / год	~0,004 \$ за абстракт на Naiku 4.5 (~1500 вход / 500 выход). Несколько тысяч публикаций в год по одной нозологии. Шум.
Хостинг + PostgreSQL	~50–150 \$ / месяц	Один небольшой инстанс плюс управляемый Postgres.
Все источники P0 по доступности и покрытию	0 \$	PBS, Минздрав Израиля, BDPM, ATIH — все бесплатны. Это и есть неожиданная находка.
Все регуляторные источники и реестры исследований	0 \$	EMA, openFDA, TGA, ClinicalTrials.gov, ANZCTR, WHO ICTRP.
Терминологии	0 \$	SNOMED CT бесплатен в Австралии и Израиле; ATC, RxNorm, UMLS, ICD — бесплатны.
Коммерческая лицензия OncoKB	НЕИЗВЕСТНО	Избегаемо — использовать CIViC.
Лицензия NCCN	НЕИЗВЕСТНО	Избегаемо — использовать ESMO.
Лицензия NICE syndication	НЕИЗВЕСТНО	Только если Великобритания станет юрисдикцией.

Статья	Стоимость	Комментарий
Юристы: основание по ст. 9 GDPR + граница SaMD	Тысячи \$, разово	Не опционально до пилота.
Патентная проверка (US 11 887 738)	Разово	Единственная позиция, способная закрыть проект.

Суммарные регулярные расходы на сторонние данные для MVP на Австралии — ноль. Не «мало», а ноль. Все источники для Q4, Q5, Q6 и Q7 по Австралии бесплатны и официальные. Вопрос бюджета — это рецензент, а затем юридическая экспертиза. Деньги этого проекта уходят не в софт и не в данные.

7 · Лицензионные ограничения, влияющие на архитектуру

OncoKB запрещено использовать для обучения ИИ-моделей

Запрет явный и распространяется и на академическое, и на коммерческое использование; бенчмаркинг допускается только с разрешения. Поскольку T3 использует LLM-извлечение, это должно быть записано в реестре источников как жёсткий флаг, а не сноска. У CIViC таких ограничений нет — это вторая причина предпочесть его.

robots.txt PBS запрещает /api/, /downloads/ и *.zip

Оценочный ZIP, который я скачал, попадает под это правило. Разовая ручная загрузка для оценки и промышленный сбор — разные вещи, но архитектурный вывод однозначен: автоматизация идёт через зарегистрированный API с ключом подписки.

У израильского API нет публичного контракта

Он работает и отдаёт богатые структурированные данные, но не документирован, не имеет SLA, и условия автоматического использования не подтверждены. Считать зависимостью, которая может исчезнуть, и до коммерческого применения спросить Минздрав.

Абстракты PubMed могут быть защищены авторским правом третьих лиц

NCBI требует, чтобы их дисклеймер был виден в ПО, использующем E-utilities, и для массовой работы направляет к локальной копии, а не к обстрелу API. Это формирует архитектуру загрузки, а не только страницу с правовой информацией.

8 · Что нужно получить до начала или параллельно с разработкой

#	Действие	Ответственный	Почему это на критическом пути
1	Получить ключ подписки к PBS API	Михаил	Промышленная загрузка не должна скачивать ZIP. Бесплатно, но это регистрация со сроком.
2	Найти конкретного онколога-рецензента и узнать его ставку	Наум	Связующее ограничение всего проекта. Без него review gate из §8 не работает, сколько бы кода ни было, и главная статья расходов остаётся неизвестной.

#	Действие	Ответственный	Почему это на критическом пути
3	Патентная проверка US 11 887 738	Наум / юрист	Единственная позиция реестра, способная прекратить проект.
4	Подтвердить смысл израильского флага health и условия автоматического использования	Михаил / Наум	Сверить 20–30 препаратов с официальным перечнем корзины и запросить Минздрав. Определяет, годится ли Израиль как вторая юрисдикция.
5	Бесплатная Affiliate-лицензия SNOMED CT	Михаил	Бесплатно, но запросить нужно до распространения.
6	Юридическая экспертиза: основание по ст. 9 GDPR и граница SaMD	Наум / юрист	Требуется до пилота с реальными пациентами, а не до запуска.

Источники

- PBS public API and rate limit: data.pbs.gov.au/api/api-public.html · PBS API base: data-api.health.gov.au/pbs/api/v3/ · robots.txt: pbs.gov.au/robots.txt
- PBS schedule CSV bundle (downloaded and parsed, Jul + Aug 2026): pbs.gov.au/publication/schedule/2026/08/2026-08-01-PBS-API-CSV-files.zip
- Israel MOH drug registry JSON API (verified by live query): israeldrugs.health.gov.il/GovServiceList/IDRServer/SearchByName
- OncoKB licensing and AI/ML restriction: faq.oncokb.org/licensing · oncokb.org/api-access
- NCCN permissions and commercial licence: nccn.org/guidelines/submissions-licensing-and-permissions/permission-to-cite-or-use-nccn-content-faq
- NICE syndication API: nice.org.uk/reusing-our-content/nice-syndication-api
- NHS dm+d via TRUD: nhsbsa.nhs.uk/pharmacies-gp-practices-and-appliance-contractors/nhs-dictionary-medicines-and-devices-dmd/release-dmd-files
- BDPM: base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/telechargement · ATIH liste en sus: atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-l-information/medicaments
- EMA medicine data downloads: ema.europa.eu/node/82422 · openFDA authentication: open.fda.gov/apis/authentication
- ClinicalTrials.gov API v2: clinicaltrials.gov/data-api/about-api · NLM v2 release note: nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma24/ma24_clinicaltrials_api.html
- PubMed E-utilities usage guidelines: ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25497/
- Crossref + Retraction Watch: crossref.org/documentation/retrieve-metadata/retraction-watch/
- SNOMED CT licensing and Members: snomed.org/get-snomed · snomed.org/members
- WHO ATC/DDD toolkit: who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification
- myTomorrows: mytomorrows.com · US patent 11,887,738: image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11887738